

Un adulto autistico più anziano nella vostra RSA / équipe infermieristica

Per il personale di RSA, case di riposo e infermieristica di comunità — sostenere un adulto autistico più anziano (circa 60+), diagnosticato o no.

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un adulto più anziano si è sempre chiusa in pochi „tunnel” profondi e intensi. Questa è la **parte meno studiata dell'arco di vita autistico**, e gli ambienti di cura sono spesso i **più difficili** — ostili sul piano sensoriale, dirompenti per la routine, pieni di contatto e richieste imprevedibili. Molti ospiti autistici più anziani non sono mai stati individuati. Proteggere routine, interessi e oggetti lifelong; abbassare il carico; comunicare alla lettera; e separare con cura la differenza autistica dalla demenza sono il cuore di una cura buona e dignitosa.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Evita le cure, „non gli piace entrare”, si ritira	Esperienze negative lifelong + barriere sensoriali/comunicative — non non-collaborazione
Malessere ai cambi di routine, stanza o personale	Prevedibilità e oggetti sono ancore di identità e sicurezza
Non segnala dolore; presentazione tardiva	Differenze di interocezione ; „non si lamenta” ≠ „non soffre”
Risposte lente, inusuali; sembra confuso	Spesso tempo di elaborazione + differenza autistica lifelong — non necessariamente demenza
Esaurimento, perdita di competenze	Forse decenni di burnout accumulato

Provate questo

- **Costruite le cure attorno alla prevedibilità:** personale costante, stessa sequenza, preavviso di ogni cambio.
- **Protegete routine, interessi e oggetti lifelong** — rimuoverli „per la sicurezza” può causare un danno reale.
- **Indagate prima il dolore e le cause fisiche** per ogni nuovo malessere o declino.
- **Comunicate in modo chiaro, letterale e lento**, per iscritto dove aiuta; concedete ampio tempo di elaborazione; usate il decision-making supportato.
- **Riducete il carico sensoriale** e tenete conto dei cali di udito/vista che si sommano alle differenze lifelong.

Da evitare

- Liquidare le differenze lifelong come „solo invecchiamento”, o il burnout come depressione.
- Disruptare le routine o rimuovere oggetti significativi nelle cure.
- Presupporre l'incapacità cognitiva da una risposta lenta o atipica — valutate, non presupponete.

Quando chiedere altro supporto

Il dubbio **demenza-o-differenza-autistica?** è davvero difficile e poco studiato — non presupponete; cercate una valutazione **informata sull'autismo** (i test standard possono fraintendere i tratti autistici). State attenti al **burnout autistico** (spesso decenni nella sua formazione) e all'**isolamento sociale** (un rischio maggiore). Siate trasparenti sulle scarse evidenze in vecchiaia.

Se la persona è una donna

Le donne autistiche più anziane sono un gruppo particolarmente sotto-individuato, avendo mascherato per una vita; una storia di „ansia“, mal-diagnosi o burnout accanto a una differenza lifelong merita seria considerazione dell'autismo.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parte 5, RSA e ospedali), la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parti 3.5 e 4) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Le evidenze sull'età avanzata sono scarse; siate onesti sull'incertezza.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Dwyer (2025); Klein et al. (2024, invecchiamento e autismo); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024); OAR (invecchiamento nello spettro); NTG (autismo e demenza). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.